PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Excesso de treinamento

Overreaching funcional, não funcional e síndrome do overtraining

Fisiologia Hormonal e Endocrinologia do Exercício

A diferença não é o sintoma; é o tempo de volta

mais grave →

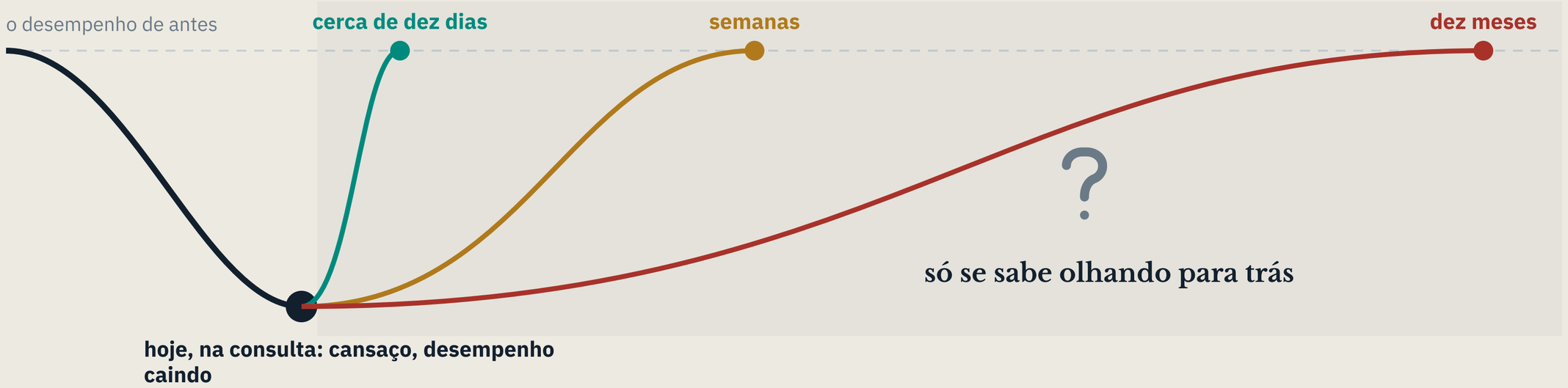
Overreaching funcional	Overreaching não funcional	Síndrome do overtraining
volta em	volta em	volta em
dias, raramente semanas	**semanas, às vezes meses**	**vários meses a anos**

> A síndrome é diagnóstico de exclusão.

Meeusen e colaboradores, consenso ECSS e ACSM, Medicine and Science in Sports and Exercise 2013

A COISA MAIS IMPORTANTE DA AULA

O diagnóstico é retrospectivo

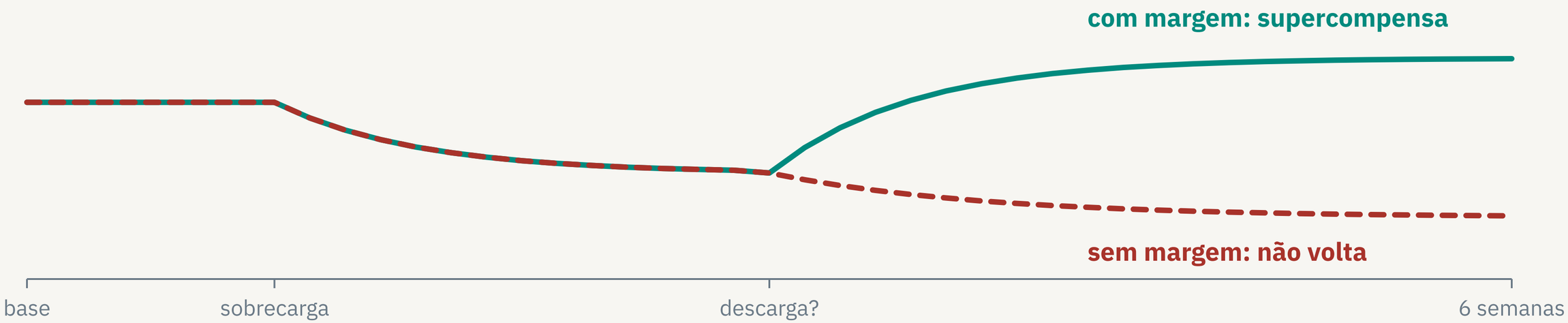


> A boa notícia: a primeira conduta é parecida nos três.

Esquema, sem valores medidos

OVERREACHING FUNCIONAL

Ferramenta de atleta com margem



Planejado, curto e seguido de descarga real. Em quem trabalha doze horas e dorme cinco, é um empréstimo que não tem como pagar.

Esquema, sem valores medidos

O QUE EXISTE COMO CRITÉRIO

Cada palavra carrega trabalho

Queda de desempenho — pressupõe um “antes” medido

inexplicada, — obriga o diferencial

apesar de repouso adequado, — carga bem reduzida por semanas

com sintomas, — fadiga, sono, humor, apetite, infecções

outras causas afastadas — diagnóstico de exclusão

Nenhum exame

nenhum hormônio, nenhuma razão entre marcadores

Meeusen e colaboradores, consenso ECSS e ACSM 2013

UMA REVISÃO DE 2002

“Que ferramentas diagnósticas nós temos?”



publicações sobre o tema

mais de vinte anos depois, mudou pouco



instrumentos válidos

medir antes do quadro — ninguém sabe quem vai entrar nele

o quadro aparece

o padrão-ouro confirma — olhando para trás

dois testes com 4 horas de intervalo

protocolo de pesquisa hormonal, não de consultório

Painel que “diagnostica overtraining” vende o que não existe. Relação testosterona-cortisol: reconhecer, não decidir.

Urhausen e Kindermann, Sports Medicine 2002 · Meeusen e colaboradores 2013

O QUE FUNCIONA

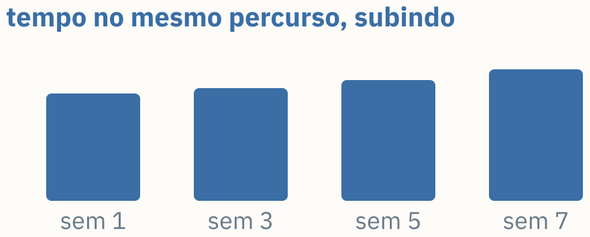
Três instrumentos, nenhum de sangue

O histórico de carga escrito vale mais que os três

às vezes a carga não mudou; mudou a vida

Teste padronizado repetido

mesmo percurso ou carga, mesma condição



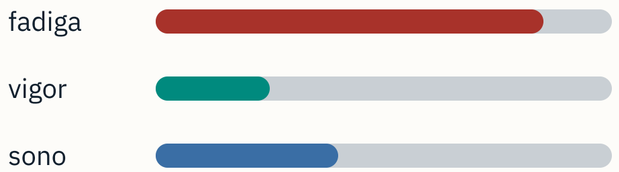
Esforço para carga fixa

mesma carga, percepção subindo por semanas



Humor e recuperação

questionários validados: mais fadiga, menos vigor



Esquemas, sem valores medidos

UMA REVISÃO SISTEMÁTICA, 2016

A pergunta bem feita supera o exame

a carga aumenta

Medidas subjetivas

- bem-estar
- sono percebido
- dor muscular
- estresse
- humor

responderam à carga de forma mais sensível e consistente

Objetivas habituais

- frequência cardíaca de repouso
- marcadores de sangue

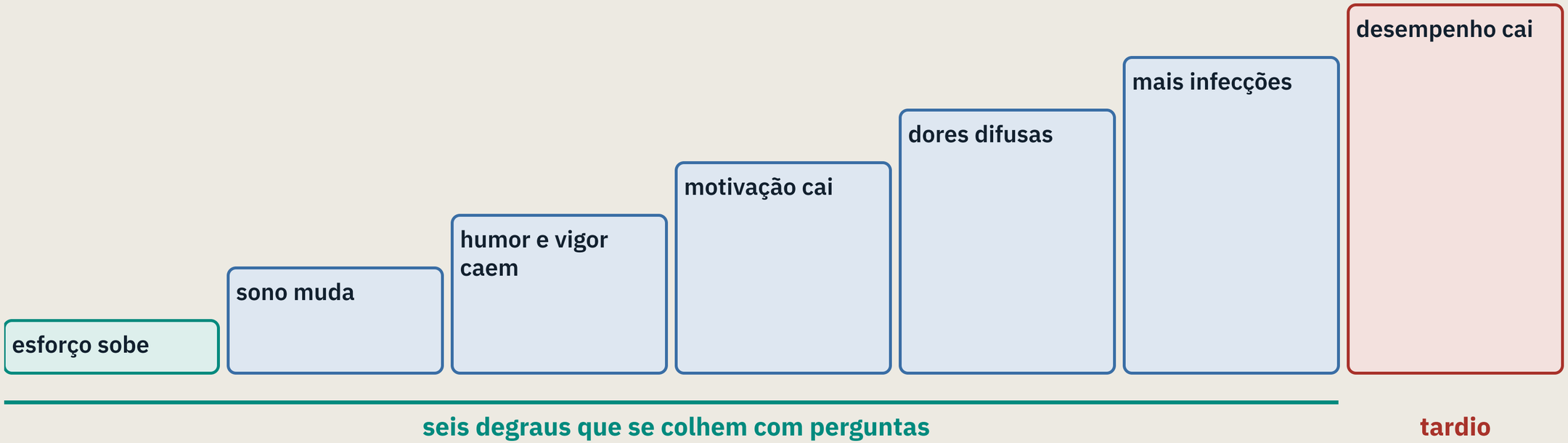
responderam menos

> O problema não é que falte instrumento. É que o instrumento que funciona não parece instrumento.

Saw, Main e Gastin, British Journal of Sports Medicine 2016 · indicadores: esquema, sem valores medidos

O QUE MUDA ANTES

Quando o desempenho cai, você já está atrasado



Ordem aproximada da prática, não sequência medida em estudo · os seis primeiros são inespecíficos: não dispensam o diferencial

A ENCRUZILHADA

Manter a carga, ou reduzir e reavaliar

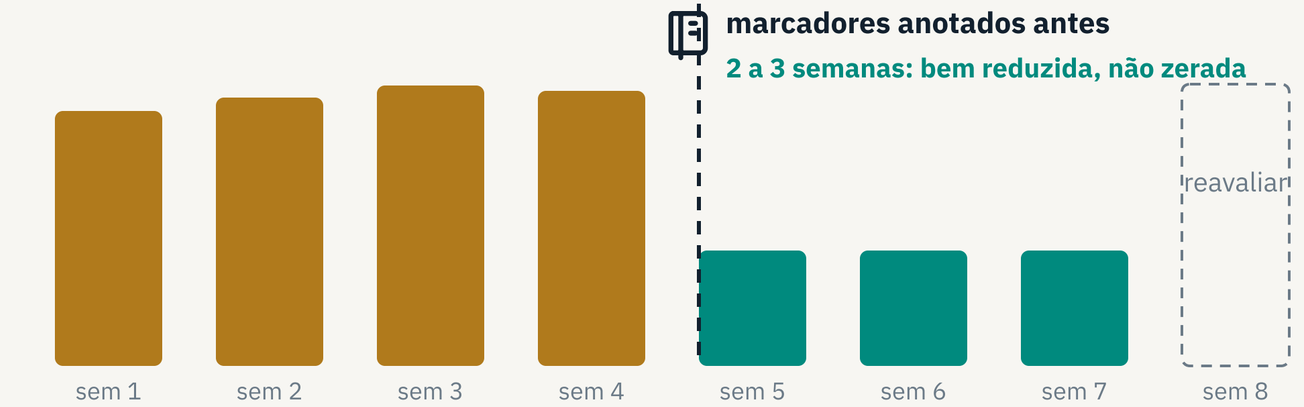
A: manter, como se fosse funcional

só com as duas:

- [ ] sobrecarga planejada e curta
- [ ] descarga real que a vida permite cumprir

faltou uma: está fora

B: o teste de descarga



frequência e alguma intensidade curta mantidas

Avise que os primeiros dias vão ser ruins. Sem aviso, a pessoa abandona no terceiro dia achando que precisava treinar mais.

Barras: esquema, sem valores medidos

SAÍDA C E O CRITÉRIO

B e C em paralelo; A precisa ser justificada

C: investigar antes de mexer

- perda de peso sem intenção, febre, suor noturno
- gânglios, falta de ar desproporcional, dor no peito
- palpitação com sensação de desmaio, ideação suicida
- fadiga de meses sem mudança de carga

Reavaliar em 4 a 6 semanas



- [x] esforço na mesma sessão
- [x] qualidade do sono
- [x] vigor e motivação numa escala simples
- [x] teste padronizado, com data

A primeira conduta é a mesma nos três estados, e reduzir carga não atrapalha investigação nenhuma.

CINCO EIXOS NA MESMA DIREÇÃO

Uma decisão executada em cinco lugares

- Cortisol sem voltar ao basal · gonadal suprimido · T3 baixo com TSH normal
- IGF-1 baixo · sinais periféricos avisando escassez
- A carga estava alta demais para o que essa pessoa podia sustentar naquele período

Médico

Investiga causas; as bandeiras da saída C são o gatilho.

Preparador e educador físico

Ajustam a carga e montam a descarga: primeira linha.

Todo mundo

Reconhece os seis primeiros degraus da escada.

Entre o primeiro degrau e o sétimo está a janela em que isso ainda é barato de resolver.